EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 75417
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 07-12-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA OLGA FUENTES MORALES			RUN	: 6.352.788-2
F.Nac	: 08-12-2020	Edad	: 2 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-12-01	Fecha Egreso	: 07-12-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. D01.0-CARCINOMA IN SITU DE COLON

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Dolor Oncológico
- Cancer De Colon Metastasico A Higado Y Parrilla Costal
- Metastasis Caderas?
- Celulitis Cadera Izquierda
- Cirugia Reciente Artroplastia Parcial Cadera Derecha
- Anemia crónica

DIAGNÓSTICOS CIE10
1. D01.0-CARCINOMA IN SITU DE COLON (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 86 años, con antecedentes HTA, DM NIR, Cáncer gástrico operado en 1994, Cáncer de colon operado en 2020 con metástasis hepáticas actualmente en CP, portadora de prótesis de cadera Derecha. Sin alergias conocidas. Derivada desde HODOM ingresada posterior a Cirugia Artroplastia parcial cadera derecha 02.11.2023 para tto atb y curaciones, presentar dolor en cadera izquierda, asociado a aumento de volumen edema, mayor compromiso del estado general. Al ingreso con tendencia a la hipertensión, normosaturando, Normocardica, físico Glasgow 14 pts, leve desorientada, pálida, piel tibia, mucosas hidratadas, yugulares planas, tórax simétrico expansible dolor en cadera izquierda + enrojecimiento leve y aumento de volumen ++, extremidades inferiores sin edema. Además presenta úlcera sacra cavitada, de 5cm de diámetro y 3 cm de profundidad aproximadamente, exudativa . Se realiza examenes de laboratorio Creatinina : 0,70 mg/dl Proteina C Reactiva : 180,6 * mg/L
Recuento de leucocitos : 11,00 mil/ul Dimero D : 2.627,1 * ng/mL INR : 1,30 TC Abdomen Y Pelvis Con Contraste
Impresión: Múltiples lesiones hepáticas sugerentes de localizaciones secundarias.
Ateromatosis aortoilíaca extensa. Se ingresa para manejo del dolo con buena evolucion.
Evaluada por traumatología DR GUSTAVO MUÑOZ PEÑA sin indicación de tratamiento actualmente por traumatologia
Curaciones dia por medio cadera derecha para evitar infeccion de esta. Se toma conocimiento del caso, pcte con reciente artroplastia parcial de cadera derecha por fractura. En contexto de Ca de Colon Mtt.
EF: deshicencia superficial distal de herida operatoria cadera derecha sin signos locales de infeccion, con salida de escasa secreción serohematica. Sin lesiones cadera izqda actualmente.
Cirugia evelua la ulcera sacra india ca curaciones avanzadas por lo que se indica alta nuevamente con hodon con curaciones avanzadas y control poli de del dolor .

PLAN DE MANEJO:

Alta Medica
Curaciones avanzadas

Control poili del dolor
Continuar con tto crónico

INDICACIONES AL ALTA

1. Régimen: Hiposódico para Diabetico
2. Cuidados Y Prevención De Upp
3. Dexametasona 4 Mg Al Dia Ev
4. Celebra 200 Mg 1 Por Dia Vo
5. Fierro 200 GR Dia Vo
6. Acido Folico 5 Mg Dia Vo
7. Omeprazol 20 Mg Dia Vo
8. Pregabalina 75 Mg Dia VO
9. Dabigatarn 150 Mg Por Dia (Suspender En Caso De Sangrado Activo)
10. Transtec 2 Parche Cada 3 Dias.
11. Curacion De herida Cada 48 horas

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO